
**RESUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT**

FOLIFER®

Antianémique

1. Dénomination du médicament

FOLIFER

2. Composition qualitative et quantitative

Chaque comprimé est constitué par un noyau central contenant 90 mg de fer (sous la forme de sulfate ferreux) de libération modifiée et une couche avec 1mg d'acide folique de libération immédiate.

Pour tous les excipients voir rubrique 6.1.

3. Forme pharmaceutique

Comprimés pelliculés.

4. Données cliniques

4.1. Indications thérapeutiques

Les principales actions thérapeutiques du FOLIFER sont la prophylaxie ou traitement des états de carence en fer et acide folique, dans la grossesse, l'accouchement et l'allaitement de longue durée. Le fer est indiqué dans tous les états de carence, soit par défaut d'apport soit pour augmentation des besoins. Il est particulièrement indiqué dans la prévention et traitement des anémies de la grossesse et de l'accouchement. On utilise l'acide folique pour prévenir ou traiter les déficiences qui peuvent survenir dans quelques états physiologiques (par exemple, grossesse, allaitement et croissance), dans plusieurs pathologies (par exemple, anémie macrocytaire et mégaloblastique, syndromes de malabsorption, sprue, stéatorrhée idiopathique, maladie d'Whipple), patients soumis à thérapeutique anticonvulsivante et alcooliques.

4.2. Posologie et mode d'administration

Sauf indication médicale en contraire, on doit avaler 1 comprimé de FOLIFER par jour, à prendre entier, avec de l'eau ou du jus de fruits (éviter le lait), de préférence avec l'estomac vide. En cas de survenue d'effets irritatifs gastriques on recommande l'ingestion de FOLIFER après un repas (déjeuner ou dîner). La durée du traitement doit être établie par le médecin. En cas d'oubli d'une ou plusieurs doses, on doit continuer le traitement normalement selon indication médicale.

4.3. Contre-indications

Hypersensibilité connue à quelqu'un des composants. Surcharge martiale de fer dans l'organisme (par exemple, hémochromatose, hémolyse chronique). Anémie mégaloblastique par carence de vitamine B₁₂.

4.4. Mises en garde et Précautions d'Emploi

Exceptionnellement il peut survenir de l'hypersensibilité à l'acide folique. Utiliser avec précaution en cas d'affections aiguës du tractus digestif. Avec l'administration du fer, une coloration noire des selles est habituelle. Contient du lactose. Ce médicament est contre-indiqué chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction

L'utilisation concomitant de fer (sels) par voie injectable est déconseillée parce que il peut conduire à lipothymie, voir choc attribué à la libération rapide du fer de sa forme complexe et à la saturation de la sidérophiline.

Il faut prendre en compte l'utilisation concomitante d'antiacides parce qu'ils diminuent l'absorption du fer. La réponse thérapeutique au fer peut être retardée par le chloramphénicol.

Prendre des précautions en cas d'association à tétracyclines, méthyldopa, quinolones, pénicillamine et anticonvulsivants. Le fer diminue l'absorption des tétracyclines et vice-versa, diminue l'absorption et altère le métabolisme de la méthyldopa, pouvant affecter

son efficacité anti-hypertenseuse. L'administration concomitante d'une préparation de fer oral, peut interférer avec l'absorption de quelques quinolones (e.g. ofloxacin, ciprofloxacine, norfloxacine). L'effet cuprodiurétique de la pénicillamine est affecté par le fer oral, probablement par diminution de son absorption. Quand nécessaire on doit administrer ces produits à distance de 2 heures, minimum.

L'acide folique peut interférer avec les anticonvulsivants, pouvant augmenter la fréquence des crises.

La vitamine C augment l'absorption du fer.

4.6. Grossesse et allaitement

L'utilisation de fer et acide folique pendant la grossesse et l'allaitement est sûre, et d'ailleurs deux de ses indications.

4.7. Effets sur l'aptitude à conduire et à utiliser des machines

On ne connaît pas d'effets.

4.8. Effets indésirables

Il y a la possibilité d'intolérance digestive, traduite par des douleurs abdominales, brûlures gastriques, nausées, constipation ou diarrhée, dues à l'ingestion de fer. Exceptionnellement il peut survenir des phénomènes d'hypersensibilité à l'acide folique, se manifestant par bronchospasme, érythème, fièvre ou prurit. La survenue d'une coloration noire des selles n'a aucune signification pathologique et est due à l'excrétion du fer.

4.9. Surdosage

L'ingestion massive, presque toujours chez l'enfant, peut originer des problèmes graves relativement au surdosage de fer, puisque l'acide folique n'est pas toxique. La symptomatologie se manifeste par irritation digestive, nausées, vomissements et état de choc. On doit réaliser immédiatement lavage gastrique avec du bicarbonate de sodium à 1%.

5. Propriétés pharmacologiques

5.1. Propriétés pharmacodynamiques

Code ATC: B03AD-03 – Fer (sulfate ferreux) en association avec de l'acide folique.

FOLIFER est une spécialité pharmaceutique contenant, comme principes actifs, deux importants micronutriments - le fer et l'acide folique. Le fer se trouve sous la forme de sulfate ferreux et il est libéré lentement à partir du noyau du comprimé, tandis que l'acide folique présente dans la périphérie est de libération plus rapide.

L'ion fer est indispensable pour la synthèse de l'hémoglobine et de la myoglobine - des composants nécessaires au transport et utilisation d'oxygène. Le fer entre aussi dans la composition d'un grand nombre d'enzymes participantes dans la transférence d'énergie, comme est le cas de la cytochrome-oxydase, la xanthine oxydase et la déhydrogénase succinique. La carence en fer est due essentiellement à un apport insuffisant (anorexie, maladies gastro-intestinales, diètes pauvres) ou à une augmentation des pertes (menstruation, pertes occultes, etc.). L'incidence de carence en fer chez les femmes menstruées est évaluée en 10-20%.

L'acide folique (acide ptéroylglutamique) est une vitamine indispensable dans plusieurs réactions métaboliques essentielles à la vie, notamment à la synthèse des purines et pyrimidines, et interconversion des acides aminés (sérine en glycine, histidine en acide glutamique, homo cystéine en méthionine).

L'hématopoïèse est le point d'appui de l'action conjointe du fer et de l'acide folique. Toutes les fois qu'elle se trouve augmentée il y a de la mobilisation du fer et du folate des réserves organiques. Aussi, quand il y a perte de sang vers l'extérieur, n'importe l'étiologie ou la localisation de l'hémorragie, cette mobilisation est mise en épreuve. Pour que le balance se maintient, il sera nécessaire un apport dans la diète en ces nutriments que, d'ailleurs, coexistent partiellement dans beaucoup d'aliments. Des besoins ou des pertes augmentées et non équilibrées par l'alimentation sont les causes principales

d'anémie. On doit avoir présent la possibilité d'une anémie ferriprive être accompagnée par une carence profonde en folates, en n'oubliant pas que le déficit de fer peut masquer le déficit de folates et donc diffuser le diagnostic de cette dernière carence et à son tour, le déficit en folates peut embarrasser la réticulocytose induite par l'administration de fer. Dans les deux cas, la correction de la carence d'un de ces nutriments implique toujours l'augmentation de l'apport de l'autre, lequel doit, donc, être présent en quantité suffisante pour faciliter l'hématopoïèse.

Dans la grossesse, l'intérêt de l'association fer/acide folique est en rapport non seulement avec le métabolisme hémoglobinique, mais aussi avec tout le processus de développement foeto-placentaire, et pourtant son utilisation préventive est universellement admise.

5.2. Propriétés pharmacocinétiques

Fer: L'absorption du *fer* se fait surtout dans le duodène et le jejunus et elle est influencée par plusieurs facteurs dont on souligne le degré des réserves existantes, le rythme de l'érythropoïèse et la forme d'administration (le sulfate ferreux est un sel qui présente une bonne biodisponibilité).

En fait, tant chez l'homme que chez la femme post-ménopausée, le métabolisme du *fer* se réalise en système fermé, c'est à dire, la plupart du *fer* libéré par la destruction des érythrocytes vieillissants est réutilisé. Ainsi, dans ces cas, une anémie ferropénique est presque toujours en rapport avec des pertes sanguines pathologiques.

Toutefois, chez les femmes en âge de procréer, et étant donné les pertes par la menstruation, les besoins sont presque le double de l'homme et de la femme post-ménopausée.

Les variations dans la quantité du flux menstruel et/ou dans sa fréquence se manifestent sur les dépôts organiques en *fer* et représentent une cause relativement fréquente d'anémie.

À son tour, la gestation est une situation physiologique dans laquelle les besoins de *fer* sont extraordinairement augmentés (un total d'environ 800 mg pour une gestation normale) spécialement dans le troisième trimestre, une période dont les besoins fœtales sont maximales.

Cela demande une utilisation, chaque fois plus grande, des réserves maternelles qui, en règle, ne sont pas suffisamment extensibles (environ 300 mg) pour couvrir ces valeurs et, à son tour, l'alimentation rarement contient une grande quantité de fer permettant faire face aux 6-7 mg journalières nécessaires.

L'*acide folique* est absorbé dans la partie proximale de l'intestin grêle et il est rapidement réduit en acide tétra-hydrofolique, lequel accepte des chaînes monocarbonées en position 5 ou 10 pour originer les suivants coenzymes actifs: 5-méthyl-tétrahydrofolique, 5-formil-tétrahydrofolique, 10-formil-tétrahydrofolique, 5,10-méthényl-tétrahydrofolique, 5,10-méthylène-tétrahydrofolique, 5-formimine-tétrahydrofolique et 10-hydroxyméthyl-tétrahydrofolique.

Les divers composants ainsi originés se trouvent à l'intérieur des cellules sous la forme de polyglutamates lesquels ne s'épandent pas vers l'espace extracellulaire.

L'*acide folique* est une vitamine hydrosoluble étant rénale la principale route d'excrétion. Comme la plupart de l'absorption se réalise dans la partie proximale de l'intestin grêle il est fréquente la survenue de carences en folates quand il y a pathologie du jéjunum (sprue, stéatorrhée). Aussi dans l'alcoolisme aiguë et chronique, et dans les maladies caractérisées par un "turnover" élevé, tels que les anémies hémolytiques héréditaires, chez les malades prenant des inhibiteurs de la réductase du dihydrofolate comme le trimetoprim et le méthotrexate, ou ceux prenant des médicaments interférant avec l'absorption et stockage des folates dans les tissus, tels que certains anticonvulsivants et les contraceptifs oraux, il peut survenir des états de carence.

5.3. Données de sécurité précliniques

Le fer et l'acide folique sont largement connus et utilisés dans la clinique. Les données disponibles dans des études chez l'animal n'offrent pas des questions de sûreté.

6. Données pharmaceutiques

6.1. Liste des excipients

Polyvidone, acide citrique anhydre, amidon de maïs, lactose, stéarate de magnésium, eudragit, talc et opadry.

6.2. Incompatibilités

Inconnues.

6.3. Durée de conservation

Deux ans.

6.4. Précautions particulières de conservation

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur

Blister de polyamide/aluminium/PVC avec 10 comprimés, conditionnés sous boîtes de 60 comprimés et une littérature médicale.

6.6. Précautions particulières d'élimination

Non applicable.

Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

7. Nom et raison sociale du titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché

BIAL – Portela & C^a, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugal

8. Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché

17.1.1.1677

9. Date de la première autorisation/de renouvellement de l'autorisation

Date de première autorisation: 29 septembre 2003

Date de dernière renouvellement de l'autorisation: 15 novembre 2013

10. Date de Mise à jour du texte